

GASTROSCOPIA

Raisa Quiñones Castro, Carmen Villar Lucas, Pedro Linares Torres.

INTRODUCCIÓN

Qué es

La endoscopia digestiva alta es una técnica que permite mediante la utilización de un gastroscopio la visualización de esófago, estómago y duodeno con intención diagnóstica y también terapéutica en caso necesario.

Procedimiento

El gastroscopio es un tubo flexible que posee un canal con una cámara con luz que permite visualizar el interior del tubo digestivo e introducir a través de él material para realizar terapéutica. Para ello se coloca al paciente en decúbito lateral con la cabeza un poco elevada con una almohada y se introduce el endoscopio en la boca a través de un mordedor.

Previamente a la realización de esta prueba el paciente debe ser debidamente informado del procedimiento, la indicación y las posibles complicaciones, firmando un consentimiento informado por escrito. Según la indicación y el entorno, la gastroscopia se puede realizar únicamente con anestesia tópica en la orofaringe o con una sedación superficial controlada por gastroenterólogo o anestesista, con monitorización de constantes. Consideraciones previas:

- Se recomienda periodo de ayunas de al menos 6 horas (a excepción de los casos urgentes).
- Interrogar sobre alergias y antecedentes personales
- No se recomienda profilaxis antibiótica
- Revisar la medicación habitual del paciente, especialmente anticoagulantes y antiagregantes

ANEXO 1: MANEJO DE LOS ANTICOAGULANTES Y ANTIAGREGANTES EN ENDOSCOPIA.

FÁRMACOS	TIEMPO
SINTROM	SUSPENDER 5 DÍAS ANTES Y PASE A HBPM
NUEVOS ACO	SUSPENDER 48 HORAS ANTES
ADIRO 100	NO ES NECESARIO SUSPENDER
ADIRO 300	ENTRE 5 Y 7 DÍAS ANTES, PASE A ADIRO 100
OTROS ANTIAGREGANTES	7 DÍAS ANTES Y PASE A ADIRO 100.

*Valorar en conjunto con MAP, cardiología y hematología, en situaciones de alto riesgo cardiovascular (implante stent reciente, TVP...). En ciertos casos puede ser necesario retrasar la endoscopia hasta que sea posible el ajuste de tratamiento

La duración de la exploración será de entre 5 y 30 minutos y dependerá de diferentes factores, principalmente de si es necesario realizar terapéutica o no.

Indicaciones

Persistencia de síntomas digestivos altos a pesar de terapia apropiada
 Síntomas digestivos altos asociados con signos o síntomas sugestivos de enfermedad orgánica (anorexia, pérdida de peso...) o de nueva aparición en >50 años
 Disfagia u odinofagia
 Síntomas de reflujo gastroesofágico refractarios a tratamiento
 Vómitos persistentes de causa desconocida
 Síndromes de poliposis familiar
 Hemorragia gastrointestinal: Sangrado activo o reciente, o sospecha de sangrado (pérdidas crónicas, anemia ferropénica)
 Seguimiento de lesiones premalignas, como el esófago de Barrett
 Tratamiento hemostático de lesiones sangrantes, como úlceras, tumores, lesiones vasculares...

Extracción de cuerpos extraños
 Resección de pólipos
 Dilatación de estenosis
 Colocación de gastrostomía percutánea
 Tratamiento de la acalasia (inyección de toxina botulínica, dilatación con balón...)
 Tratamiento paliativo de neoplasias (colocación de stents...)
 Diagnóstico y/o tratamiento de varices esofágicas/esofagogástricas
 Evaluación del daño mucoso tras ingesta cáustica
 Confirmación y diagnóstico histológico de lesiones diagnosticadas en prueba de imagen: lesiones sospechosas de malignidad, úlceras, estenosis u obstrucción del tracto digestivo alto

Contraindicaciones

- Sospecha de perforación visceral
- Siempre que los riesgos superen a los posibles beneficios

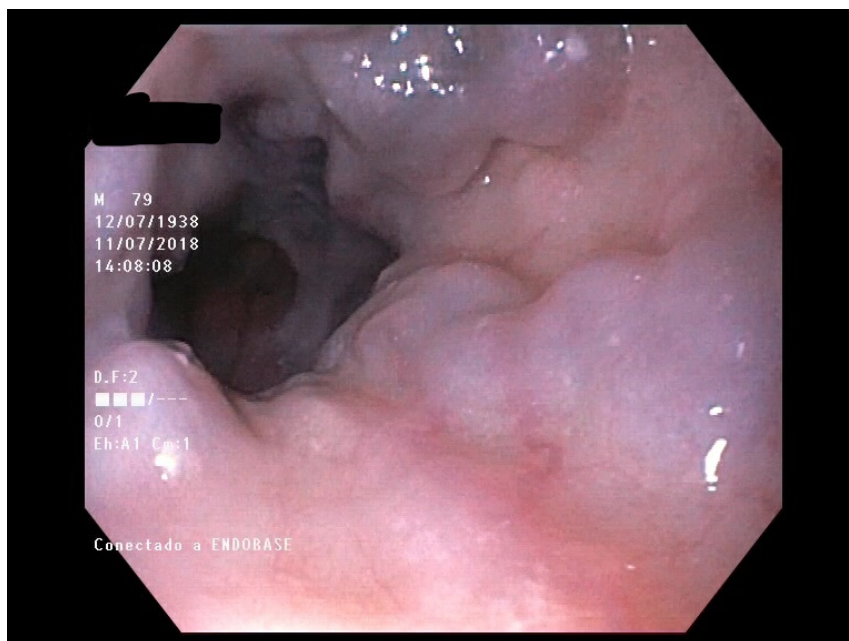
Complicaciones

La gastroscopia es un procedimiento seguro, siendo muy infrecuentes las complicaciones. La perforación ocurre en el 0,05-0,7% de los casos. El 60% de los efectos adversos son de tipo cardiopulmonar y son más frecuentes en procedimientos con sedación.

- Perforación
- Sangrado secundario a trauma o biopsia
- Infección
- Complicaciones cardiopulmonares (broncoaspiración)
- Interpretación inadecuada



Úlcus duodenal



Varices esofágicas grado III

Gastrostomía endoscópica percutánea

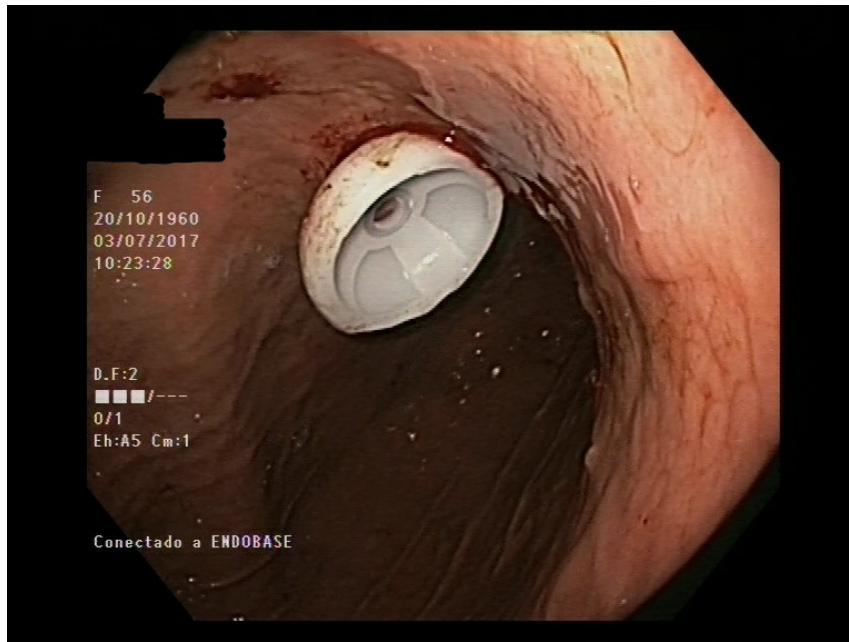
La gastrostomía consiste en la inserción de una sonda de nutrición enteral a través de la pared abdominal, realizando una comunicación directa con el estómago. En la actualidad la mayoría se realizan guiadas por radiología (GIR) o mediante endoscopia alta (PEG). El primer recambio debe realizarse en entorno hospitalario con el mismo método a los 2-3 meses de su inserción, cambiándose por una sonda con balón. Esta sonda tiene la ventaja de que se puede recambiar de forma ambulatoria por médicos generales e incluso enfermería.

Indicaciones de realizar recambio: deterioro de la sonda o el estoma, rotura del balón, pérdida o arrancamiento de la sonda. Con una buena higiene pueden tener una duración de 6-8 meses

Es muy importante en caso de pérdida de la sonda evitar el cierre de la ostomía, colocando de forma lo más temprana posible una sonda Foley o similar en su lugar

Procedimiento de recambio:

- Desinfectar la zona del estoma
- Comprobar el correcto funcionamiento del globo y la permeabilidad de la sonda en el exterior
- Deshinchar el globo, lubricar la sonda e introducirla por el estoma.
- Hinchar el globo con 20cc de suero y realizar tracción



BIBLIOGRAFÍA

- Cécil Essentials of medicine. Chapter: Endoscopic and Imaging procedures (Chistopher S. Huang, M. Michael Wolfe)
- American Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE): Appropriate use of gastrointestinal endoscopy. Gastrointestinal Endoscopy, 2012;75: 1127-1131
- Phenninger and Fowler's procedures for primary care. Chapter 101. 699-714. Edward G. Zurad